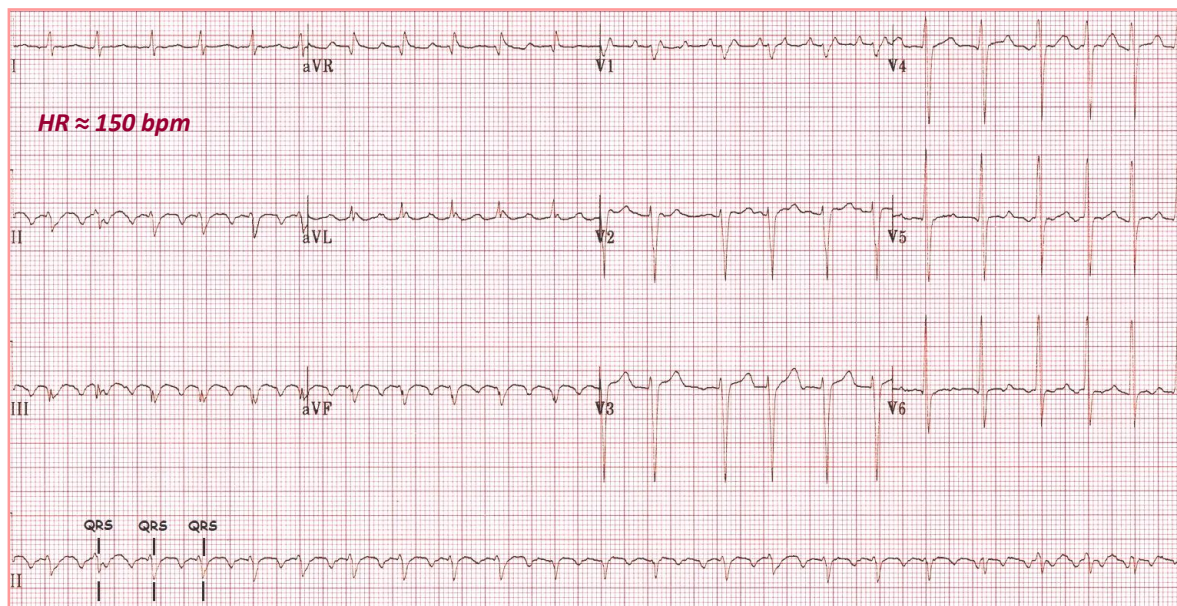
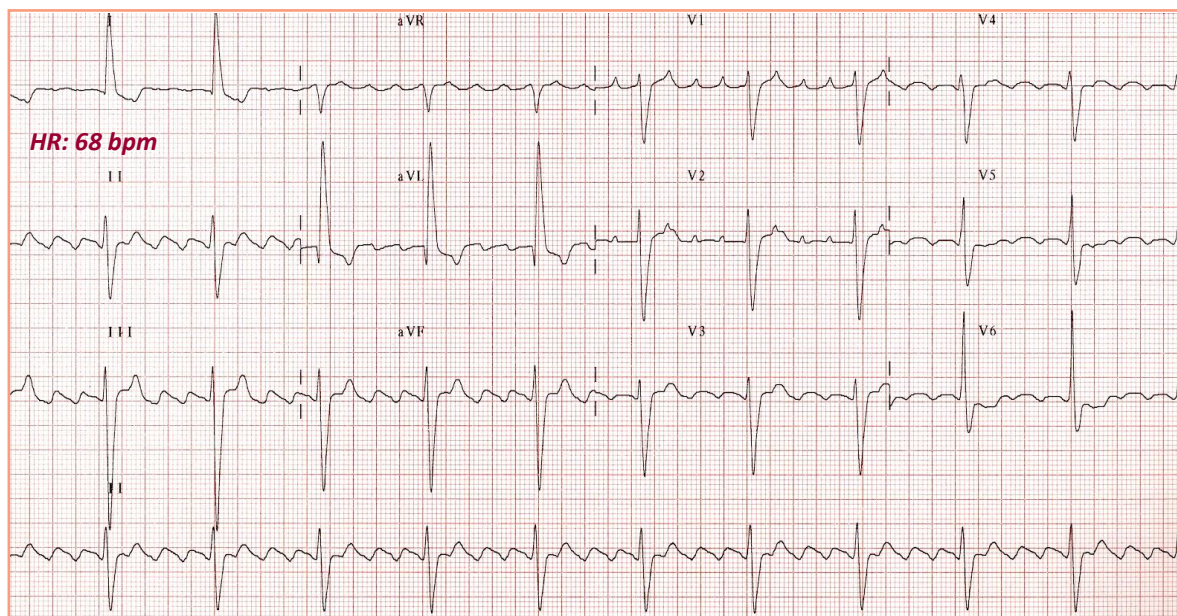


Κολπικός Πτερυγισμός – Atrial Flutter (A-Flu)

- Πρόκειται για την πλέον υποδιαγνώσιμη ταχυαρρυθμία. Ο κολπικός ρυθμός κυμαίνεται μεταξύ 250-350 παλμών/λεπτό. Πρόκειται για αρρυθμία οφειλόμενη σε μηχανισμό επανεισόδου, το κύκλωμα της οποίας εντοπίζεται αποκλειστικά στο κολπικό μυοκάρδιο.
- Περιλαμβάνει πριονοειδή κολπικά κύματα, που είναι καλύτερα ορατά στις κατώτερες απαγωγές II, III aVF (αρνητικά κύματα), καθώς και στην απαγωγή V₁ (θετικά κύματα).
- Τυπικά, εμφανίζεται με 2:1 κολποκοιλιακό (κ-Κ) αποκλεισμό, αν και περιστασιακά μπορεί να είναι ακανόνιστος με μη σταθερή κολποκοιλιακή αγωγή (πτερυγομαρμαρυγή). Εμφανίζεται συχνότερα σε άνδρες και τα συμπτώματα μπορεί να είναι αίσθημα παλμών, δύσπνοια, αδυναμία, αίσθημα κόπωσης, σύγχυση, ζάλη, τάση για λιποθυμία, κ.ά.



- Εμφανίζεται συχνότερα σε ασθενείς με ισχαιμική καρδιοπάθεια. Επίσης, σε ασθενείς με στένωση της μιτροειδούς, ΣΚΑ, OEM, πνευμονική εμβολή, μυοκαρδίτιδα, τοξικότητα εκ διγοξίνης, υπερθυρεοειδισμό (θυρεοτοξίκωση), βαριά αναιμία, κλειστό τραύμα θώρακος, χρόνια πνευμονική νόσο, πνευμονική υπέρταση, αλκοολισμό, χρήση κοκαΐνης, κ.ά.
- Σε αμφισβητούμενες περιπτώσεις διάγνωσης, η μάλαξη του καρωτιδικού κόλπου και ο χειρισμός Valsalva είναι χρήσιμες τεχνικές για να μειωθεί η κοιλιακή ανταπόκριση (VR) με την αύξηση του κ-Κ αποκλεισμού, γεγονός που θα αποκαλύψει τα πτερυγικά κύματα.



Θεραπευτική παρέμβαση

1. Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία (ΑΠ, σφύξεις, SpO_2 , $\theta^{\circ}C$), εξασφαλίζουμε φλεβική πρόσβαση, χορηγούμε O_2 και προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε ή/και να αντιμετωπίσουμε τον πιθανό αιτιολογικό παράγοντα ο οποίος πυροδότησε την αρρυθμία. Η θεραπευτική αντιμετώπιση συνίσταται είτε στον έλεγχο (επιβράδυνση) της κοιλιακής συχνότητας, είτε στην ανάταξη της αρρυθμίας σε φλεβοκομβικό ρυθμό (SR).
2. Σε ασθενείς αιμοδυναμικά ασταθείς (π.χ. επί κολπικού πτερυγισμού με ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση) και σε όσους αναφέρουν έναρξη συμπτωμάτων λιγότερο από 48 ώρες, επιχειρούμε **συγχρονισμένη ηλεκτρική καρδιοανάταξη** με ενέργεια $\approx 70-120$ Joules, ενώ σε κάθε απινίδωση αυξάνουμε την ενέργεια κατά 50 J, μέχρι να επιτευχθεί η ανάταξη. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας καρδιοανάταξης, θα χρειαστεί μικρή καταστολή με Διαζεπάμη (10-20 mg Stedon, iv), καθώς και αναλγησία με Μορφίνη (2-4 mg, iv).
3. **Φαρμακευτική ανάταξη**, μπορεί να επιχειρηθεί σε ασθενείς με έναρξη συμπτωμάτων λιγότερο από 48 ώρες και σχετικά φυσιολογική καρδιακή λειτουργία, με τη χορήγηση **Αμιωδαρόνης** (2 amp. Angoron των 150 mg, εντός ορού 250 ml D₅W, χορηγώντας το ήμισυ του διαλύματος εντός 7-10 λεπτών, από συνολικό χρόνο έγχυσης 30 λεπτών).
4. Εναλλακτικά, μπορεί να χορηγηθεί ενδοφλεβίως **Ιβουτιλίδη** 0,01 mg/kg ΒΣ (διαλύουμε 1 amp. Corvert 10 ml εντός ορού 100 ml NaCl 0,9%) σε διάστημα 10 λεπτών (επιτυχής ανάταξη στο 60-80% των ασθενών). Απαιτείται όμως, ιδιαίτερη προσοχή διότι μπορεί να προκαλέσει βαρύτερες αρρυθμίες (π.χ. Torsade de pointes) σε ασθενείς με δομικές ή λειτουργικές καρδιοπάθειες. Για αυτόν το λόγο προηγείται η χορήγηση 1-2 gr $MgSO_4$.
5. Οι σταθεροί ασθενείς με κολπικό πτερυγισμό αγνώστου ενάρξεως ή διάρκειας άνω των 48 ωρών χρειάζονται προφυλακτική αγωγή με **Ηπαρίνη** (UFH: 80 IU/kg, iv-bolus και στη συνέχεια στάγδην έγχυση, με ρυθμό 18 IU/kg/h, για 6-12 ώρες). Η αντιπηκτική αγωγή πρέπει να συνεχιστεί κατ' οίκον, τουλάχιστον για 3-4 εβδομάδες, προτού επιχειρηθεί ηλεκτρική ή φαρμακευτική ανάταξη της αρρυθμίας, στο νοσοκομείο, μετά από έλεγχο.
6. **Ο έλεγχος του καρδιακού ρυθμού** και η επιβράδυνση της κοιλιακής ανταπόκρισης (σε ασθενείς με φυσιολογική καρδιακή λειτουργία) μπορεί να γίνει με ενδοφλέβια χορήγηση **Βεραπαμίλης** 5-10 mg (αναρροφούμε 1-2 amp. Isoptin των 5 mg μαζί με 10-15 ml N/S και χορηγούμε βραδέως ενδοφλεβίως εντός 1-2 λεπτών). Για την αποφυγή του κινδύνου υπότασης και βραδυκαρδίας, λόγω της Βεραπαμίλης, πριν από τη χορήγησή της δίνουμε 10 ml Γλυκονικό Ασβέστιο 10% (1 amp.) ενδοφλεβίως, σε διάστημα 5-10 λεπτών.
7. Εναλλακτικά, στους ασθενείς με επηρεασμένη την καρδιακή λειτουργία, μπορούμε να χορηγήσουμε ενδοφλεβίως **Διγοξίνη** 0,5 mg, εντός 15-30 λεπτών (ήτοι 1 amp. Digoxin του 0,5 mg, εντός ορού 100 ml N/S). Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά **Αμιωδαρόνη** (150 mg εντός 250 ml D₅W, χορηγώντας το διάλυμα εντός 20-30 λεπτών).

- ✓ Οι ενδείξεις για τη χορήγηση αντιαιμοπεταλιακής αγωγής (Salospir, Plavix) ή αντιπηκτικής αγωγής (Sintrom, NOACs) είναι πανομοιότυπες με εκείνες που αφορούν στους ασθενείς με ιστορικό κολπικής μαρμαρυγής, τόσο για την ανάταξη της αρρυθμίας όσο και στη διάρκεια διατήρησης του καρδιακού ρυθμού σε φλεβοκομβικό ρυθμό.
- ✓ Η μακροχρόνια χορήγηση ειδικών αντιαρρυθμικών φαρμάκων (κλάσεως Ia, Ic & III) για την πρόληψη του κολπικού πτερυγισμού περιορίζεται συχνά από το υψηλό ποσοστό υποτροπών της αρρυθμίας και τελικά, ως λυσιτελής θεραπεία εκλογής, θεωρείται η κατάλυση (Ablation) του τριγωνικού ισθμού με υψίσυχο ρεύμα.

